



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA SKP
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I 3

PENDAHULUAN 3

 1.1 Latar Belakang 3

 1.2 Dasar Hukum 3

 1.3 Tujuan 4

BAB II 5

GAMBARAN UMUM 5

 2.1 Visi 5

 2.2 Misi 5

 2.3 Motto 5

 2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama 5

 2.5 SOTK 6

BAB III 7

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 7

 3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 7

 3.2 Sasaran 7

 3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan 9

 3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026 9

 3.5 Kebutuhan Anggaran 9

BAB IV 11

MONITORING DAN EVALUASI 11

 8.1 Monitoring 11

 8.2 Evaluasi 11

BAB V 12

PENCATATAN DAN PELAPORAN 12

BAB VI 13

PENUTUP 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, maka rumah sakit harus melakukan upaya peningkatan mutu dan pelayanan medic baik melalui akreditasi, sertifikasi, ataupun proses peningkatan mutu lainnya.

Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitatif (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Sasaran keselamatan pasien adalah untuk mendorong rumah sakit agar melakukan perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran ini menyoroti bagian-bagian yang bermasalah dalam pelayanan rumah sakit dan menjelaskan bukti serta solusi dari consensus para ahli atas permasalahan ini.

Sasaran keselamatan pasien wajib diterapkan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar WHO Patient Safety (2007) yang digunakan juga oleh pemerintah. Tujuan SKP adalah mendorong rumah sakit melakukan perbaikan-perbaikan yang menunjang tercapainya keselamatan pasien. Sasaran-sasaran dalam SKP menyoroti bidang-bidang yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan, memberikan bukti dan solusi hasil consensus yang berdasarkan nasihat para pakar serta penelitian berbasis bukti.

Di Indonesia secara nasional untuk seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, diberlakukan Sasaran Keselamatan Pasien Nasional yang terdiri dari :

1. Sasaran 1 mengidentifikasi pasien dengan benar
2. Sasaran 2 meningkatkan komunikasi yang efektif
3. Sasaran 3 meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai
4. Sasaran 4 memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ tindakan invasive
5. Sasaran 5 mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, dan
6. Sasaran 6 mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh

Kesalahan dalam 6 sasaran keselamatan pasien ini dapat terjadi di semua aspek pelayanan baik diagnosis, proses pengobatan serta tindakan. Sehingga dengan adanya peraturan dalam SKP ini membantu untuk mengurangi atau bahkan mencegah insiden keselamatan pasien yang sehingga nantinya akan meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit ini.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Mendorong seluruh staf rumah sakit terutama PPA melakukan tindakan yang menunjang tercapainya keselamatan pasien.

2. Tujuan Khusus

3. Mengidentifikasi pasien sebagai individu yang akan diberi layanan, tindakan atau pengobatan tertentu secara tepat.
4. Mencocokkan layanan atau perawatan yang akan diberikan dengan pasien yang akan menerima layanan.
5. Mendeskripsikan prosedur untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam identifikasi pasien selama perawatan di rumah sakit.
6. Mengurangi kejadian / kesalahan yang berhubungan dengan salah identifikasi. Kesalahan ini dapat berupa: salah pasien, kesalahan prosedur, kesalahan medikasi, kesalahan transfusi, dan kesalahan pemeriksaan diagnostik.serta pelaksanaannya sangat memperhatikan keselamatan pasien serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
7. Melakukan komunikasi lisan dan/atau telepon diantara PPA secara efektif
8. Melakukan proses pelaporan hasil kritis pada pemeriksaan diagnostic termasuk point of care testing (POCT) secara efektif dan terstandar
9. Proses komunikasi serah terima/ hand over antar PPA, antar unit perawatan yang berada dalam rumah sakit, dan dari ruang perawatan pasien ke unit layanan diagnostic terjadi dengan benar.
10. Mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam komunikasi dan meningkatkan keselamatan pasien
11. Menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi (high alert medication) termasuk obat Look Alike Sound Alike (LASA).
12. Menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (medication safety).
13. Menurunkan angka kesalahan penggunaan obat.
14. Terjadinya proses penandaan sisi operasi/ invasive sebelum tindakan dilakukan
15. Verifikasi terhadap sisi yang benar, prosedur yang benar dan pasien yang benar terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku
16. Tidak terjadi kesalahan tindakan jika penandaan sisi operasi/ invasive tidak dilakukan
17. Menurunkan angka kejadian infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya secara bermakna (Menurunkan HAIs).
18. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi.
19. Mengidentifikasi pasien yang memiliki risiko tinggi jatuh dengan menggunakan "Asesmen Risiko Jatuh".
20. Melakukan asesmen ulang pada semua pasien (setiap hari)
21. Melakukan asesmen yang berkesinambungan terhadap pasien yang berisiko jatuh dengan menggunakan "Asesmen Risiko Jatuh Harian"
22. Menetapkan standar pencegahan dan penanganan risiko jatuh secara komprehensif

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

2.3 Motto

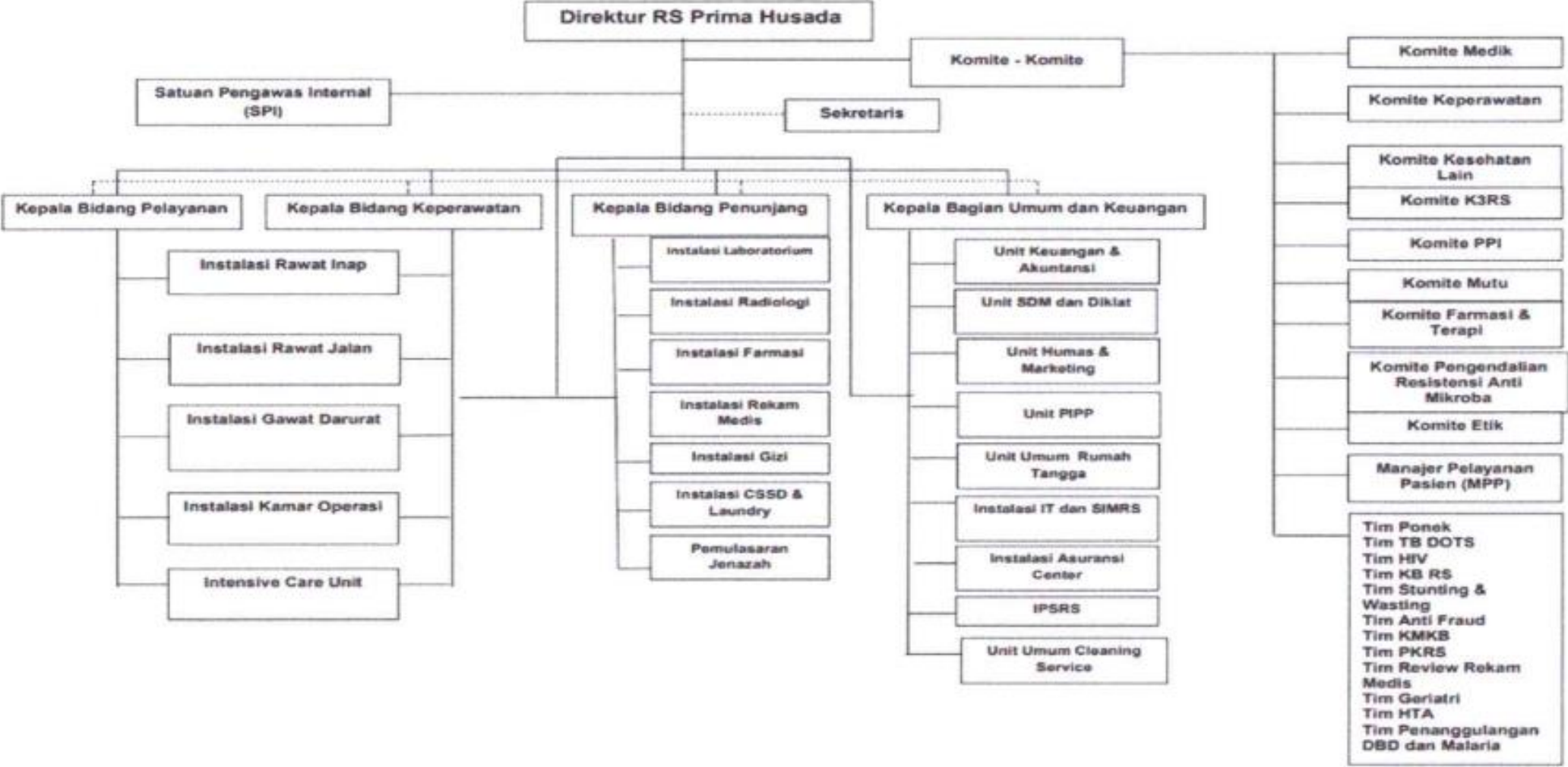
“Sahabat Menuju Sehat”

2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur dan dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK



BAB III

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Tabel 3.1 Kegiatan pokok dan rincian kegiatan SKP 2026

No	PROGRAM POKOK	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	SDM SKP	Kebutuhan SDM	• Sudah tersedia TIM SKP
2	Pendidikan dan Pelatihan	Seminar Sasaran Keselamatan Pasien	• Melakuna kegiatan 6 sasaran keselamatan pasien • Mengidentifikasi pasien dengan benar • Meningkatkan komunikasi yang efektif • Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai • Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/Tindakan invasive • Dikurangnya resiko infeksi terkait pelayanan kesehatn • Dikurangnya resiko cedera akibat pasien jatuh

3.2 Sasaran

1. Semua staf di area rumah sakit, semua orang yang berada dan melakukan aktifitas di rumah sakit yaitu tenaga kesehatan (medis dan non medis), tenaga non kesehatan (house keeping, satpam, tukang parkir, kantin dan lain-lain), pasien, keluarga pasien dan pengunjung.
2. Semua area di rumah sakit termasuk (rawat inap, rawat jalan, Laboratorium, CSSD, Laundry, Gizi, Farmasi, kamar jenazah dll) dan non pelayanan pasien (Rekam medik, sanitasi, keuangan, kepegawaian dll) serta fasilitas umum (ruang tunggu, parkir, kantin dll).
3. Rincian sasaran kegiatan:

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	Menentukan kebutuhan SDM anggota SKP	Memastikan SDM SKP mencukupi sesuai standar	• Semua unit kerja	SK	• Kesesuaian SDM SKP	• Tersusunnya SK	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
2	Melakukan Identifikasi Pasien dengan Benar	Evaluasi	• All unit	Data	• 100%	Tercapainya target/standar pada laporan setiap bulannya.	-
3	Meningkatkan Komunikasi yang efektif	Evaluasi	• All unit	Data	• Sudah dilaksanakannya komunikasi efektif secara benar sesuai standart	• Tercapainya target tidak ditemukan kejadian pelaporan yang tidak sesuai	-
3	Meningkatkan Keamanan obat yang perlu diwaspadai	Mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat	• All unit	Data	• Tidak ada laporan kejadian salah pemberian obat.	Tercapainya target pada Laporan	-
4	Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar pada pembedahan/Tindakan invasif	Meningkatkan kepatuhan penandaan operasi	• All unit	Data	Sudah dilaksanakannya penandaan operasi oleh DPJP	Tercapainya target pada Laporan	-
5	Dikurangnya resiko infeksi akibat perawatan kesehan	Mencegah penyebaran infeksi antara satu dengan lainnya.	• All unit	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI.	-
6	Dikurangnya resiko cedera akibat pasien jatuh.	Mencegah pasien jatuh saat dalam perawatan	• Unit perawatan pasien	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan.	-

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Menentukan kebutuhan SDM SKP	- Melakukan pemetaan jumlah unit kerja & beban kerja tim SKP	Wawancara	-	Triwulan atau sesuai kebutuhan	- Usulan SK Komite SKP	-
2	Melakukan pelatihan/ seminar 6 sasaran keselamatan pasien	- memberikan pelatihan 6 sasaran keselamatan pasien	seminar	PPT	1 tahun sekali	- umandok	-

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Meonitoring identifikasi pasien	All unit	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit	Tim SKP karu	-	-
2	Monitoring meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai	All unit											☑	☑	All unit	Tim SKP Karu	-	-
3	Monitoring penandaan operasi	All unit	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit	Tim SKP Karu	-	-
4	Monitoring cuci tangan	All unit	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit	IPCLN Karu	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
																IPCN		
5	Monitoring pencegahan resiko pasien jatuh.	Unit perawatan pasien, poli, pdf, IGD	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Unit perawatan pasien	Tim SKP Karu	-	-

Anggaran Kebutuhan Biaya Pengembangan SDM Tim SKP Tahun 2026

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal/Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Pelatihan SKP	Internal	120 orang	Rp. 5.000	Rp. 600.000
TOTAL					Rp. 600.000

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah disetujui oleh PT Disa Prima Medika.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

8.1 Monitoring

Monitoring kegiatan dilaksanakan setiap waktu secara berjenjang mulai dari unit sendiri, kepala ruang, Tim SKP, dan seterusnya. Monitoring dilakukan secara rutin dan dilakukan pencatatan pada form monitoring yang nantinya akan dilaporkan kepada Direksi. Pada saat monitoring dilakukan tindak lanjut secara langsung atas temuan yang dapat langsung dilakukan tindak lanjutnya.

8.2 Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program dilaksanakan pada akhir tahun.

Evaluasi dilakukan pula dalam bentuk rapat rutin yang dilakukan oleh Komite

Dokumentasi kegiatan dilakukan pada saat akhir kegiatan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi TOR, Laporan pelaksanaan, UMANDOK.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Sasaran Keselamatan Pasien di RS Prima Husada tidak bisa diwujudkan hanya dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan saja, akan tetapi dibutuhkan upaya peningkatan sistem dan pemikiran yang holistik. Evaluasi kegiatan yang dilakukan di semua unit kerja.

.

BAB VI PENUTUP

Program kerja ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Sasaran keselamatan pasien RS Prima Husada Malang. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan mutu pelayanan RS Prima Husada Malang

Malang, 1 Desember 2025
Tim SKP



Khusnul Khotimah

Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes